

KC桌面——外资精译

GS：手握150亿欧元现金，赛诺菲的转型之路为何仍存疑？

寻找更积极理由，但管线重建尚需时日且估值不足

在经历一段研发失望期后，尽管商业引擎强劲，我们认为赛诺菲仍处于转型期。我们认为，并购/业务拓展仍是公司推动上行空间的关键杠杆（潜在交易能力达150亿欧元）。然而，鉴于整个行业的需求，资产竞争可能加剧。纵观当前产品组合，duvakitug可能是推动上行空间的关键资产；但数据预计要到2028年下半年才能获得，且利润需与梯瓦共享。虽然部分读者仍对itepekimab的机会持乐观态度，但我们认为阿斯利康的tozorakimab带来的积极惊喜削弱了这一预期。进入2026年第二季度业绩期，我们与市场共识基本一致，并预计2026年全年指引将得到重申。鉴于这将是新任CEO的首份业绩报告，我们预计只会对战略进行高层级评论，重点将放在初步印象和需要解决的关键领域（我们认为，鉴于商业执行一直强劲，这些领域可能包括研发生产力和并购/业务拓展）。对我们而言，重建市场对赛诺菲研发引擎的信心（特别是考虑到近期研发负责人变动），以及后度普利尤单抗时代的成长，可能都需要时间。因此，我们更新公司观点。

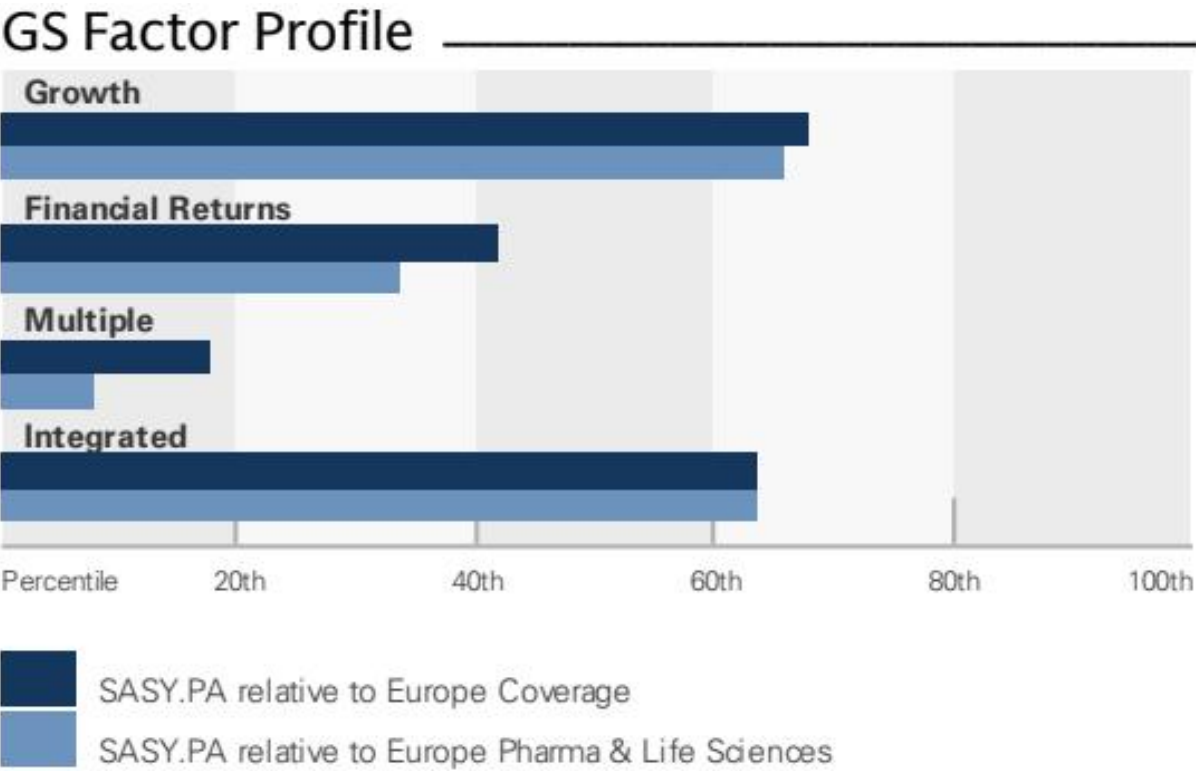
赛诺菲将于英国夏令时7月30日6:30公布2026年第二季度业绩

2026年第二季度预览：GS预测销售额略低于（约-1%）市场共识，业务营业利润和业务每股收益与共识一致，我们预计指引将得到重申。我们对度普利尤单抗的预测与共识基本一致（+1%），对Altuviiiio的预测高出2%，对Ayvakit的预测低于1%。对于2026年第二季度，我们预测汇率对销售额的影响为-1.7%，对每股收益的影响为-2.2%。在财报电话会议上，我们预计焦点将是CEO对公司/战略的初步看法，以及对研发管线的潜在影响。

中性：公司情况更新

关键数据：公司情况更新

市值：912亿欧元 / 1044亿美元 企业价值：1039亿欧元 / 1193亿美元 三个月平均日交易量：1.904亿欧元 / 2.212亿美元 法国 欧洲制药与生命科学 并购排名：3 租赁包含在净债务和企业价值中？：是

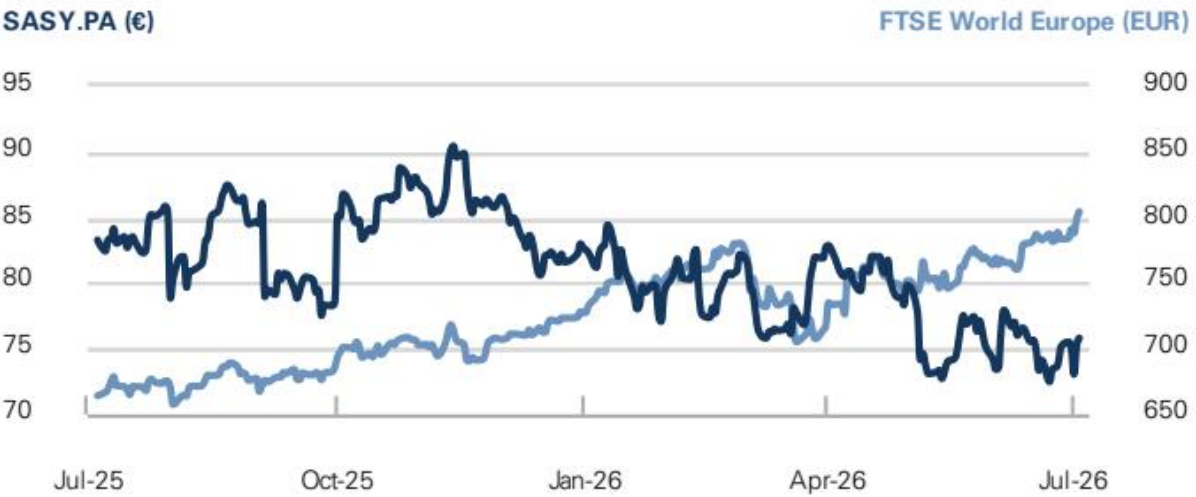


图表 1

来源：公司数据，GS估计。详情请参阅披露信息。

比率与估值

资产负债表（百万欧元）



图表 2

现金流量表（百万欧元）

来源：公司数据，GS估计。来源：FactSet。价格截至2026年7月3日收盘。

利润表（百万欧元）

优先级排序，以及对资本配置策略的任何重新评估，特别是近期免疫学领域的活动相关的业务发展和并购。我们还预计市场将关注2026年度普利尤单抗的动态，关键考虑因素包括潜在生命周期管理举措的任何增量更新。

公司面临的挑战：我们认为赛诺菲面临双重挑战，即平衡由度普利尤单抗驱动的近中期执行与长期产品组合更新。虽然通过生命周期管理举措延长度普利尤单抗专营权的持久性仍是近期优先事项，但赛诺菲还需要恢复读者对其能够创造下一波增长的信心。一系列研发失望事件加剧了这一挑战，包括：itepekimab的III期混合结果（

当日报价下跌5%)，amlitelimab低于预期的疗效数据（当日报价下跌8%），tolebrutinib在原发性进展型多发性硬化症中的III期失败及随后的完全回应函（当日报价下跌3%），以及近期rilipribart在慢性炎性脱髓鞘性多发性神经病中的III期MOBILIZE试验终止，这些都削弱了市场对公司创新引擎以及在度普利尤单抗之外推动收入和盈利增长能力的信心。读者可能希望看到切实证据，证明在新任CEO和研发负责人领导下，赛诺菲能够改善研发执行，推进能够支持未来商业增长的差异化后期管线，并有选择地利用纪律严明、价值增值的业务拓展/并购来填补产品组合空白。我们认为，在这些战略优先事项上展示持续进展，对于建立稳健的后度普利尤单抗增长叙事、重建对公司研发能力的信心，以及支持读者情绪和估值的复苏至关重要。

我们关注哪些因素以变得更积极/更消极：以下因素会使我们对这只公司更积极：(a) 度普利尤单抗生命周期管理取得进展，特别是通过将市场独占期延长至当前预期的2033-34年生物类似药进入窗口之后，以及有证据表明长效制剂在给药便利性之外还能提供有意义的临床获益。(b) 管线执行改善，得到关键资产积极且差异化的数据支持，包括lunsekimig（详细II期结果预计于2026年9月欧洲呼吸学会会议上公布）、frexalimab（复发型多发性硬化症的III期数据预计于2027年下半年公布）和duvakitug（溃疡性结肠炎的III期数据预计于2028年下半年公布，克罗恩病的III期数据预计于2029年下半年公布）。其他积极进展将是efdoralprin alpha成功的监管进展（2026年下半年美国提交）以及免疫肿瘤学（PD-1/IL-15）和基因治疗领域令人鼓舞的早期开发。(c) 管理层执行纪律严明、价值增值的并购，加强赛诺菲在度普利尤单抗之后的增长前景，并展示有效部署资本以获取有吸引力的商业或补充性临床阶段机会的能力。如果出现以下情况，我们会对该股变得更消极：(a) 报价在没有基本面支撑的情况下大幅重估，例如盈利预期改善、管线不确定性降低或有意义的商业催化剂，增加了未来失望的不确定性。(b) 出现进一步的管线挫折，特别是在后期开发阶段，降低了未来增长潜力，增加了对现有商业产品组合的依赖，并提高了对外部创新、许可和并购的需求，以维持长期增长。

。我们模型的关键底层更新包括：(i) 汇率更新；(ii)

鉴于近期III期MOBILIZE研究终止的更新，将riliprubart的成功概率从40%下调至10%；(iii)

鉴于tolebrutinib在非复发型继发进展型多发性硬化症中获得欧盟批准，将其成功概率从75%上调至100%；(iv)

纳入23亿欧元债券发行的影响；(v) 我们现在模拟度普利尤单抗从2033年开始面临生物类似药进入/价格不确定性，并将终端增长率从0%下调至-2%，以反映研发失望事件，这些共同导致我们的DCF估计值下降4%。

2026年第二季度预览

在更新汇率、公司评论、处方趋势和近期债券发行后，我们对2026年第二季度净销售额的预测比市场共识低约1%：我们对度普利尤单抗的预测比共识高1%，对Altuviio的预测高2%，对Ayvakit的预测低1%。对于业务营业利润和业务每股收益，我们与共识一致。

季度需考虑的关键因素

Dupixent：我们预测该季度美国销售额实现18%的固定汇率增长，美国以外地区实现17%-18%的固定汇率增长。备忘提示需关注2026年第一季度财报电话会议中关于Dupixent因上市动态而在2026年下半年面临更严峻比较基数的评论。

Altuviio：我们预测2026年第二季度销售额为3.87亿欧元，全球季度固定汇率增长率为36%，处方趋势反映出强劲的 uptake。

- Ayvakit：我们预测2026年第二季度销售额为2亿欧元，较市场共识低1%。

外汇：我们预测2026年第二季度对销售额的影响为-1.7%（备忘显示季度影响为-2%），对每股收益的影响为-2.2%（备忘显示为-3%）。我们预测全年外汇对销售额/每股收益的影响为-1.5%/-1.9%。

百万欧元及每股

Vara共识，最后更新于2026年7月1日 * Visible Alpha共识，其余为Vara共识

2026财年指引：我们预计赛诺菲将重申其当前的固定汇率指引：销售额实现高个位数增长，业务每股收益增速略快于销售额固定汇率增速。公司2026年第一季度的评论表明，随着比较基数变得更为严峻，对今年剩余时间的前景持谨慎态度，导致增长节奏变化，且2026年第一季度后公司编制的2026财年共识修正有限。总体而言，

当前指引的中点意味着2026财年共识销售额和业务每股收益预估存在适度（约1%）的节奏变化不确定性。

图表2：2026财年指引

财报电话会议的关键关注领域：(1) 近期领导层交接后可能进行的战略更新，可能对研发管线优先级产生影响，以及资本配置策略的任何重新评估，特别是考虑到近期免疫学领域的活动，涉及业务发展和并购；(2) 2026年Dupixent动态，关键考虑因素包括潜在生命周期管理举措的任何增量更新；(3) Altuviiiio和Ayvakit的商业动态及未来预期；(4) 对今年关键管线数据的评论——lunsekimig在哮喘领域的2期详细AI RCULES数据将于2026年9月在欧洲呼吸学会会议上公布，以及amlitelimab的3期ESTUARY研究，包括amlitelimab获批的前景。

可能使我们对该股更积极/更消极的因素

在近中期，我们认为新领导层面临双重挑战：延长Dupixent特许经营权的持久性，同时通过内部管线或业务发展/并购展示一条替代其销售额和盈利能力的可信路径。

我们认为以下关键进展可能使我们对该股更积极，并可能有助于重建读者对赛诺菲研发引擎的信心

- Dupixent生命周期管理举措的进展：生命周期管理仍是读者关注的关键领域，尤其是在新任CEO开始制定长期战略重点之际。更清晰地了解Dupixent市场独占期可能超出当前市场预期范围，可能通过推迟生物类似药进入（共识目前预计2033-34年生物类似药进入）带来显著的估值上行空间。此外，有证据表明长效Dupixent制剂在给药便利性之外提供有意义的差异化，例如在疗效、安全性或患者结局方面的改善，可能进一步增强该特许经营权在日益竞争激烈的市场中的持久性。
- 重建并交付管线：在经历了一段以管线失望为标志的时期后，围绕管线的情绪非常低落。有助于提升情绪的关键驱动因素包括：(a) 近期催化剂：lunsekimig在哮喘领域的详细2期数据将于2026年9月在年度欧洲呼吸学会会议上公布，itepekimab在COPD领域的未来开发路径决策，以及frexalimab在复发型多发性硬化症和非复发型继发进展型多发性硬化症中的3期结果（预计2027年下半年，主要完成日期为2027年5月）；(b) 中期价值驱动因素：duvakitug在溃疡性结肠炎和克罗恩病中的3期数据，分别预计于2028年下半年和2029年下半年公布，代表了一个在快速演变且日益竞争激烈的IBD市场中潜在的差异化机会；edoralprin alpha（一种差异化的重组AAT疗法）的获批和上市，可能在2026年下半年获得监管明确性，并因AATD相关COPD检测增加和早期诊断而带来长期上行空间；(c) 早期阶段期权价值：赛诺菲的早期管线未反映在我们的预测中，但可能随时间推移提供上行空间。PD-1×IL-15资产提供了高不确定性、高回报的下一代免疫肿瘤学机会，而基因治疗平台如果眼科和罕见病的早期临床数据令人鼓舞，可能成为更有意义的增长驱动力。
- 增值性并购：有纪律、增值性的并购可能通过增强对赛诺菲在Dupixent最终失去独占权前实现增长多元化的信心，帮助重振读者情绪。管理层已表示2026年有能力部署高达150亿欧元，我们对先前交易的分析表明，商业阶段收购提供了最快的盈利增长路径，而临床阶段补强收购提供了最强的长期回报潜力。成功的资本部署将是构建Dupixent之后下一个增长平台的重要一步。

以下因素可能使我们对该股更消极

- 缺乏基本面支撑的估值重估：如果赛诺菲报价大幅跑赢并以溢价交易，而盈利预期、管线不确定性降低或有意义的商业催化剂没有相应改善，我们可能变得更消极。我们认为，缺乏基本面支撑的估值扩张将留下有限的上行空间，同时如果预期未能实现，则增加节奏变化不确定性。
- 进一步的管线失望：额外的后期管线挫折或弱于预期的临床数据将增加我们的谨慎态度，特别是考虑到内部创新对赛诺菲中期增长前景的重要性。进一步的临床失望将降低未来收入潜力，并增加对现有商业组合以维持盈利势头的依赖，同时使赛诺菲日益依赖外部创新和并购/许可来支持长期增长。

Dupixent：通过生命周期管理还能释放多少价值？

Dupixent 仍是赛诺菲研究故事的核心支柱，并持续推动公司大部分盈利增长。在2026年第一季度，Dupixent 销售额超出市场预期约7%，贡献了集团整体营收超预期的95%。尽管我们预计 Dupixent 仍将是关键增长动力，

但我们预期其增长势头将节奏变化，赛诺菲在其2026年第一季度财报评论中也指出了这一点，因为公司正进入一个比较基数更难的时期（请注意，2025年，Dupixent 在更多疾病领域获得批准，包括慢性自发性荨麻疹（CSU - 2025年4月在美国）和大疱性类天疱疮（BP - 2025年6月在美国），并在全球范围内推进了慢性阻塞性肺疾病（COPD）的商业化推广）。

在此背景下，生命周期管理仍是读者关注的焦点领域，尤其是在新任CEO开始制定长期战略重点之际。赛诺菲为 Dupixent 的生命周期管理概述了一项“防御、扩展、创新”战略，公司强调其强大的专利组合可延续至2045年，并指出其有意积极捍卫所有专利。在我们对山德士的首次覆盖报告中（见此处），我们注意到美国生物类似药的平均上市时间大约在化合物专利到期后1.5-2年（赛诺菲近期强调，其分析表明美国生物类似药在化合物专利到期后2-6年上市）。

- 防御 - 将专利到期时间推迟至市场对生物类似药在2033-34年进入的基本假设之后，可能推动我们的DCF估值上行。读者认为 Dupixent 的化合物专利将于2031/32年到期——在美国，Dupixent 化合物专利预计于2031年3月到期，欧洲专利到期时间普遍预期为2032年9月，尽管使用方法专利可延续至2040年代初。我们与读者的讨论表明，市场的基本预期是生物类似药将在2033-34年间进入。目前，至少有六种度普利尤单抗生物类似药正在开发中（山德士、Advanz/Alvotech、Formycon、Bio-Thera、Amneal Biosciences、三星Bioepis），虽然美国生物类似药的进入可能被推迟几年，但我们预计欧洲将在专利到期后不久就有生物类似药进入。我们对美国/欧盟生物类似药市场的分析（见我们的山德士首次覆盖报告）强调，生物类似药通常在欧洲专利到期/失去市场独占权的当年（或6-12个月内）上市，但在美国的延迟可能为1.5-2年。一些读者认为，围绕知识产权延期的更明确信息可能是一个有意义的近期催化剂——然而，赛诺菲指出尚未出现专利挑战，因此也没有和解，故而没有设定时间表来向市场提供更多清晰度。我们现在模拟 Dupixent 从2033年开始面临生物类似药进入/价格不确定性，并鉴于研发方面的失望，将我们的终端增长率从0%下调至-2%，这意味着对我们的DCF估值产生-4%的影响。

- 扩展 - 长效制剂可以延长 Dupixent

产品系列的生命周期，提供更长的治疗间隔并结合值得信赖的安全性特征——我们认为这只能部分保护 Dupixent 产品系列。在2026年第一季度业绩中，赛诺菲提到了长效 Q4W Dupixent 制剂的进展，称该方法有先例可循，并通过更高浓度或与透明质酸酶联用实现。该公司强调了正在开发的用于哮喘的更高剂量 Q4W 方案，并指出将与合作伙伴再生元分享开发计划的细节。目前，开发重点集中在 Q4W 给药间隔上，而该领域已有可用选项，因此我们认为这只能部分保护该产品系列，尤其是在美国以外的市场。

- 创新 - 值得注意的是，再生元还强调了一些未纳入赛诺菲联盟的资产（具有优化结合特性的长效 IL13 和 IL4 抗体，以及长效 IL-4xIL-13 双特异性抗体）。虽然 Dupixent 的长效制剂可以提供额外的生命周期管理手段，但我们认为其商业影响尚不明确。此外，竞争格局持续演变，新兴药物如艾伯维的 zumilokibart 试图通过更不频繁的给药方案实现差异化，同时提供相当的疗效。因此，除非在疗效、安全性或患者结局方面具有明显优势，否则仅凭给药便利性可能不足以实质性延长产品系列的生命周期。联合承包的使用可能是一个驱动因素，但随着PBM改革，尚不清楚这在未来将如何保持优势。

总体而言，我们认为管理层面临双重挑战：延长 Dupixent 产品系列的持久性，同时展示一条通过内部管线或业务拓展/并购来替代其销售额和盈利能力的可信路径。以下我们概述了我们认为的关键管线机会，以及我们对价值增值型并购策略的看法。我们相信，在新领导层领导下，任何一方面的进展都可能是该股上行的关键驱动力，并有助于重振读者情绪。

恢复对赛诺菲研发引擎信心的关键管线机会会有哪些？

在经历了一段以管线失望为标志的时期之后，我们重新审视我们认为的关键管线机会，这些领域可能日益成为赛诺菲新领导层的关注焦点。尽管执行不确定性依然存在，但管线在免疫学、神经学、肿瘤学、罕见病和基因治疗领域提供了一系列近期催化剂、中期价值驱动因素和早期阶段的可选性。即使这些项目中的一部分能够成功执行，也有助于重塑读者对研发引擎的看法，并支撑一个更加多元化、长期增长的形象。我们将这些机会大致分为以下几类

近期催化剂：公司情况更新

- Frexalimab - 在复发缓解型多发性硬化症（RMS）（FREXALT）和非复发继发进展型多发性硬化症（nrSPMS）（FREVIVA）中的三期数据读出（预计分别在2027年下半年和2028年上半年，主要完成时间分别为2027年5月和2028年3月），以及向肾移植排斥反应和肾脏疾病的更广泛扩展，可能将CD40L抑制确立为一个差异化的免疫学平台。在我们的模型中，我们纳入了30亿欧元的未经调整的峰值销售额，成功概率为40%。
- Itepekimab - 在经历了复杂的开发历史以及近期阿斯利康的 tozorakimab 对该机制的积极验证之后，管理层对 itepekimab 在慢性阻塞性肺疾病（COPD）中的未来开发路径的决定仍是一个重要的近期决策。然而，鉴于 tozorakimab 数据的广度与 itepekimab 好坏参半的数据相比，我们认为 tozorakimab 处于更有利的位置。在我们的模型中，我们纳入了跨适应症25亿欧元的未经调整的峰值销售额，成功概率为20%。

中期价值驱动因素

4/11

Duvakitug——强劲的2b期诱导和维持数据已使该资产成为炎症性肠病（IBD）领域领先的TL1A项目之一，其潜在在扩展至非IBD炎症和纤维化适应症（赛诺菲希望在此领域成为快速追随者）将带来额外上升空间。来自溃疡性结肠炎（UC）和克罗恩病（CD）的SUNSCAPE 1和2以及STARSCAPE 1和2试验的3期数据预计分别于2028年下半年和2029年下半年公布。尽管IBD市场规模庞大且快速演变，但duvakitug很可能成为第三个上市的药物，这可能会限制先发优势。此外，赛诺菲尚未概述更广泛的开发或扩张战略以支持在其他适应症中的差异化。在我们的模型中，我们纳入了23亿欧元的峰值未调整销售额，成功概率（PoS）为60%。

Efdoralprin alfa——一种差异化的重组AAT疗法，预计在2026年下半年获得监管明确性，并通过提高AATD相关COPD的检测率和早期诊断带来长期上升空间。在我们的模型中，我们纳入了12亿欧元的峰值未调整销售额，成功概率（PoS）为80%。

早期阶段的可选性（鉴于这些项目处于早期阶段，我们目前未在模型中对以下资产纳入任何销售额）。

- PD-1 IL-15项目——一种新兴的肿瘤资产，旨在将检查点抑制与靶向免疫激活相结合，可能解决IL-15疗法历史上的局限性。在2026年3月的创新峰会上，赛诺菲指出了实体瘤中的PD-1xIL-15双特异性方法，描述该机制在生物学上合理并开辟了新的治疗途径，尽管仍处于早期阶段，初步数据在3L mCRC中显示出前景。
- 基因治疗组合——眼科和神经肌肉疾病的早期项目提供了长期的可选性，并可能在重新聚焦下一代治疗模式的背景下变得日益重要。

图表3：管线来源概览

近期催化剂：公司情况更新

Frexalimab

Frexalimab在复发型多发性硬化（RMS）和非复发继发进展型多发性硬化（nrSPMS）中的3期数据预计将于2027年公布，在tolebrutinib令人失望之后，这可能成为赛诺菲神经学业务的重要转折点。Frexalimab靶向CD40L通路，这是一种位于适应性免疫和先天免疫激活上游的差异化机制。从机制上讲，抑制CD40L可调节T细胞、B细胞、巨噬细胞、小胶质细胞和树突状细胞活性，而不会导致广泛的淋巴细胞耗竭，与抗CD20疗法相比，可能在疗效和免疫保护之间提供不同的平衡。我们注意到，在2026年3月的创新诊所中，关键意见领袖（KOL）对使用CD20药物进行持续B细胞抑制表示担忧（见此处）。

多发性硬化（MS）中的现有数据：在2期RMS研究中，frexalimab显示出强大的MRI疗效，高剂量组在第12周时新的钆增强T1病灶较安慰剂减少约89%，而低剂量组减少约79%。重要的是，这些效果在更长时间的随访中似乎持久，在扩展数据中观察到对炎症性MRI活动的持续抑制长达约96周。研究结果还显示，两种剂量的frexalimab均能显著减少新的或扩大的T2病灶，这是该研究的次要终点。该项目还产生了令人鼓舞的生物标志物数据，高剂量组在第48周时神经丝轻链（NfL）降低约41%，表明除了控制急性炎症外，还可能对潜在的神经轴突损伤产

生影响。安全性也被认为是积极的，特别是考虑到没有出现通常与慢性B细胞耗竭策略相关的广泛淋巴细胞耗竭、严重感染信号或免疫球蛋白抑制。

商业前景和在MS中的定位：赛诺菲还在推进frexalimab用于nrSPMS，鉴于慢性先天免疫激活和小胶质细胞生物学在进展性疾病中的作用，这最终可能为该资产带来更具差异化的机会。然而，更广泛的多发性硬化（MS）市场仍然极具挑战性（见我们关于MS的深度分析）。抗CD20疗法根深蒂固，我们预计该类疗法将保持约65%的市场份额，因为它们具有持续强劲的疗效、长期数据集和医生的熟悉度。因此，新进入者的疗效门槛很高，目前市场对frexalimab的预期在共识估计中似乎相对温和。竞争格局也日益拥挤，BTK抑制剂在RMS和进展性MS中推进，同时早期CAR-T方法也在增多。我们认为，frexalimab的机会最终可能更少取决于广泛取代CD20疗法，而更多在于为那些长期免疫保护、进展生物学或慢性治疗耐受性日益重要的患者建立差异化的定位。

其他适应症：除多发性硬化外，赛诺菲已将frexalimab的开发扩展到肾移植排斥反应（2/3期FREXERA研究，主要完成日期为2029年8月）和局灶节段性肾小球硬化症（FSGS）（2a期RESULT研究，主要完成日期为2026年12月）。在移植中，CD40/CD40L轴在T细胞活化、B细胞成熟、抗体产生和抗原呈递细胞信号传导中发挥核心作用，使其成为移植排斥反应中生物学验证最充分的共刺激通路之一。目前的标准化免疫抑制方案，主要是钙调神经磷酸酶抑制剂如他克莫司，虽然有效，但与显著的长期毒性相关，包括肾毒性、感染不确定性和心血管并发症。因此，抑制CD40L提供了更靶向的免疫调节潜力，而无需广泛的免疫耗竭。重要的是，根据研究，较新的Fc工程抗体（如frexalimab）旨在避免历史上限制早期CD40L项目的血栓栓塞问题。在FSGS中，CD40/CD40L信号传导与足细胞损伤、炎症和纤维化有关，为在进展性肾脏疾病中靶向该通路提供了依据。虽然仍处于早期，但在这些肾脏适应症上的成功可能支持这样一种观点，即CD40L调节在神经学以外的多种免疫介导环境中具有适用性，并可能显著增强对该机制以及赛诺菲更广泛创新能力的信心。

我们的估计：在我们的模型中，我们纳入了30亿欧元的峰值未调整销售额，成功概率（PoS）为40%。如果3期结果积极，将降低我们当前40% PoS的不确定性，在其他条件不变的情况下，这将使我们的DCF估值有8%的上行空间，而失败则意味着5%的节奏变化空间。

Itepekimab

中期催化剂：公司情况更新

Duvakitug 与 TL1A 机遇

Duvakitug 正逐渐成为赛诺菲管线中日益重要的资产，市场对其临床特征和商业潜力的信心不断增强。Duvakitug 在 2b 期 IBD 试验中展现了同类最佳的疗效信号，包括在诱导期和维持期均令人鼓舞的数据，增强了对应答持久性的信心。该资产目前处于该靶点类别开发时间线的第三位，紧随罗氏和该领域的领导者默克之后。除了炎症性肠病（IBD）领域（合作伙伴梯瓦制药（由 Matt Dellatore 覆盖）认为其峰值销售额潜力约为 30-50 亿美元），该项目的适应症正在积极拓展。值得注意的是，梯瓦在其 1Q26 财报电话会议上概述了三个开发方向：T2、非 T2 和纤维化疾病，并强调将基于市场规模、机制原理、监管成功概率和上市速度，采用有纪律、标准驱动的方法进行适应症优先排序，预计 2026 年全年将有进一步更新。总体而言，duvakitug 似乎正从一项相对被低估的资产，转变为一个潜在的重要增长驱动力，其上行空间不仅与 IBD 相关，还与更广泛的生命周期扩展机会相关。下文，我们将探讨其在 IBD 领域的潜力和相关性，以及 IBD 以外的机遇。

作用机制及其在 IBD 中的相关性：TL1A

是一种属于肿瘤坏死因子（TNF）超家族的细胞因子。在健康个体中，TL1A 水平会暂时升高以帮助免疫细胞抵抗感染。然而，在 IBD 患者中，TL1A 在发炎的肠黏膜中慢性过度表达。其作用机制的特点是在驱动炎症和纤维化方面发挥双重作用。该机制临床差异化的关键驱动因素在于

a) 双重作用机制（炎症 +

纤维化）及潜在的首创抗纤维化潜力：与仅靶向炎症级联反应的传统生物制剂不同，阻断 TL1A 会破坏

TL1A-DR3 轴。这不仅会下调关键的促炎细胞因子（IFN- γ 、TNF- α 、IL-17），还会直接阻止成纤维细胞活化和上皮-间充质转化。IBD（尤其是克罗恩病）中最显著未满足的需求之一是纤维狭窄（肠道狭窄）的发展。目前，尚无获批的药物治疗直接靶向 IBD 中的纤维化，使得手术肠切除成为唯一的确定性治疗方法。由于 TL1A 直接刺激成纤维细胞，抗 TL1A 抗体具有独特潜力来阻止甚至逆转胶原沉积和瘢痕形成，从根本上改变疾病的自然进程。

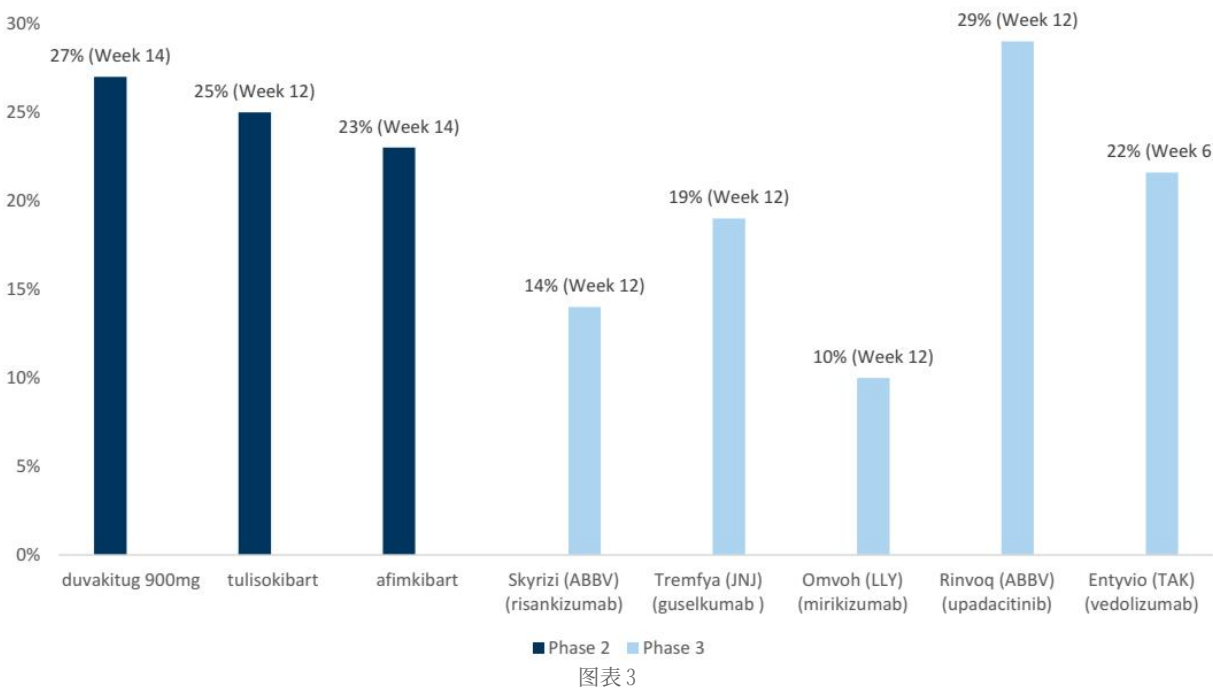
b) 提高难治性患者群体疗效上限的潜力。目前，现有生物制剂通常无法实现长期深度缓解。研究表明，约三分之一的患者对初始治疗无应答，高达 40% 的患者会随时间推移失去应答。TL1A 抑制剂在 2 期试验中已显示出稳健的临床缓解率和内镜愈合率，为多种生物制剂难治性疾病患者提供了潜在的有效选择。

c) 有利的安全性特征：早期临床数据表明，TL1A 抑制剂可能不像传统抗 TNF 疗法那样具有广泛的免疫抑制作用。通过更多地作为特定炎症和纤维化信号的放大器，而非广泛的免疫抑制剂，阻断 TL1A 可能提供更安全的长期特征，并降低感染不确定性。

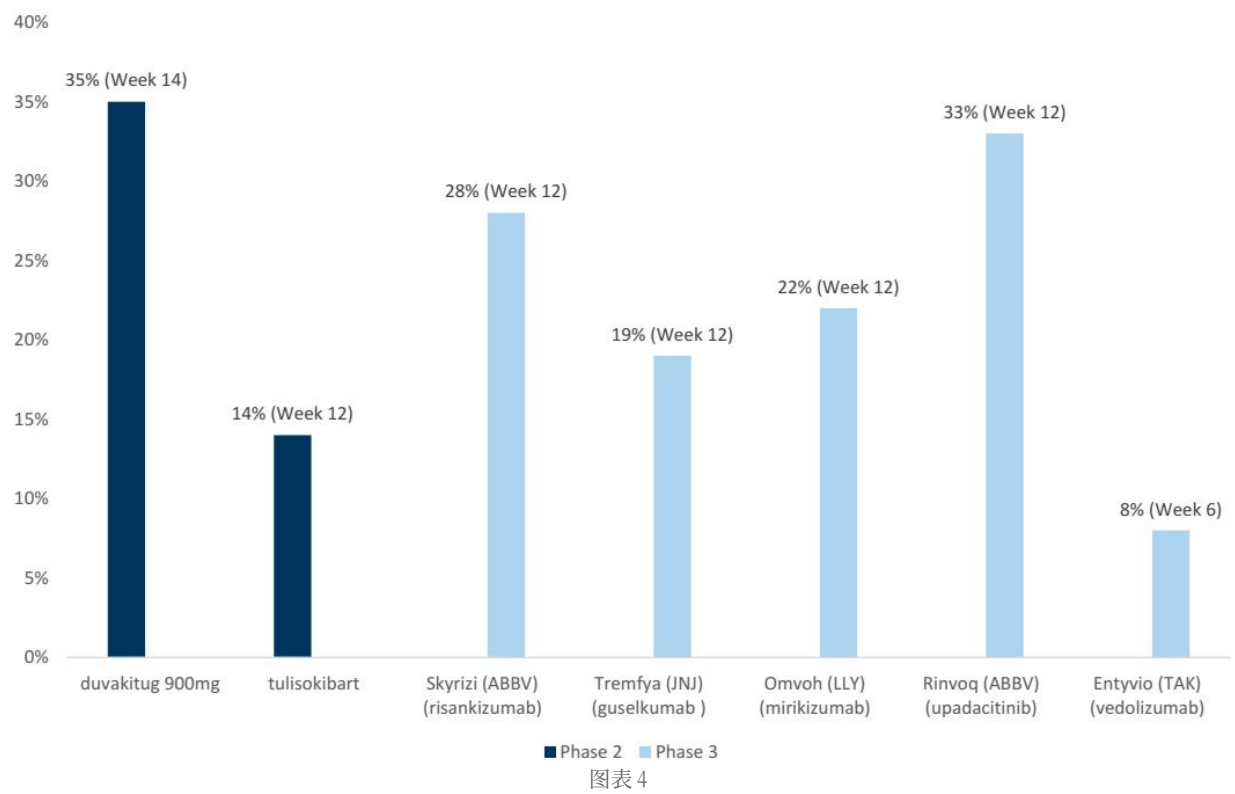
d) 实现精准医疗：编码 TL1A 蛋白的 TNFSF15 基因的遗传多态性与 IBD 不确定性和严重程度密切相关。这种遗传关联为使用分子生物标志物识别最可能对 TL1A 阻断产生应答的特定患者亚群提供了依据，从而优化试验成功概率并推动针对性的商业推广。

截至目前的数据：来自2b期RELIEVE UCCD研究的数据显示，在第14周，duvakitug对溃疡性结肠炎（UC）和克罗恩病（CD）均展现出令人信服的疗效。在UC患者中，接受duvakitug低剂量和高剂量治疗的患者分别有36.2%和47.8%达到临床缓解，而安慰剂组为20.45%——第14周时安慰剂校正后的缓解率分别为15.7%（低剂量）和27.4%（高剂量）。此外，在既往接受过先进疗法（AT）的患者亚组（低剂量和高剂量安慰剂校正响应率分别为22%和29%）和未接受过AT的患者亚组（低剂量和高剂量安慰剂校正响应率分别为12%和26%）中，duvakitug两个剂量组的临床缓解率均高于安慰剂。在CD患者中，接受duvakitug低剂量和高剂量治疗的患者分别有26.1%和47.8%达到内镜应答，而安慰剂组为13.0%——第14周时安慰剂校正后的应答率分别为13.0%（低剂量）和34.8%（高剂量）。在既往接受过AT的患者亚组（低剂量和高剂量安慰剂校正响应率分别为7%和44%）和未接受过AT的患者亚组（低剂量和高剂量安慰剂校正响应率分别为22%和29%）中，duvakitug两个剂量组的内镜应答率均高于安慰剂。维持期数据显示duvakitug具有高度差异化的特征，在900mg Q4W剂量下，UC和CD患者的临床缓解率和内镜应答率分别达到58%和55%，且安全性良好。

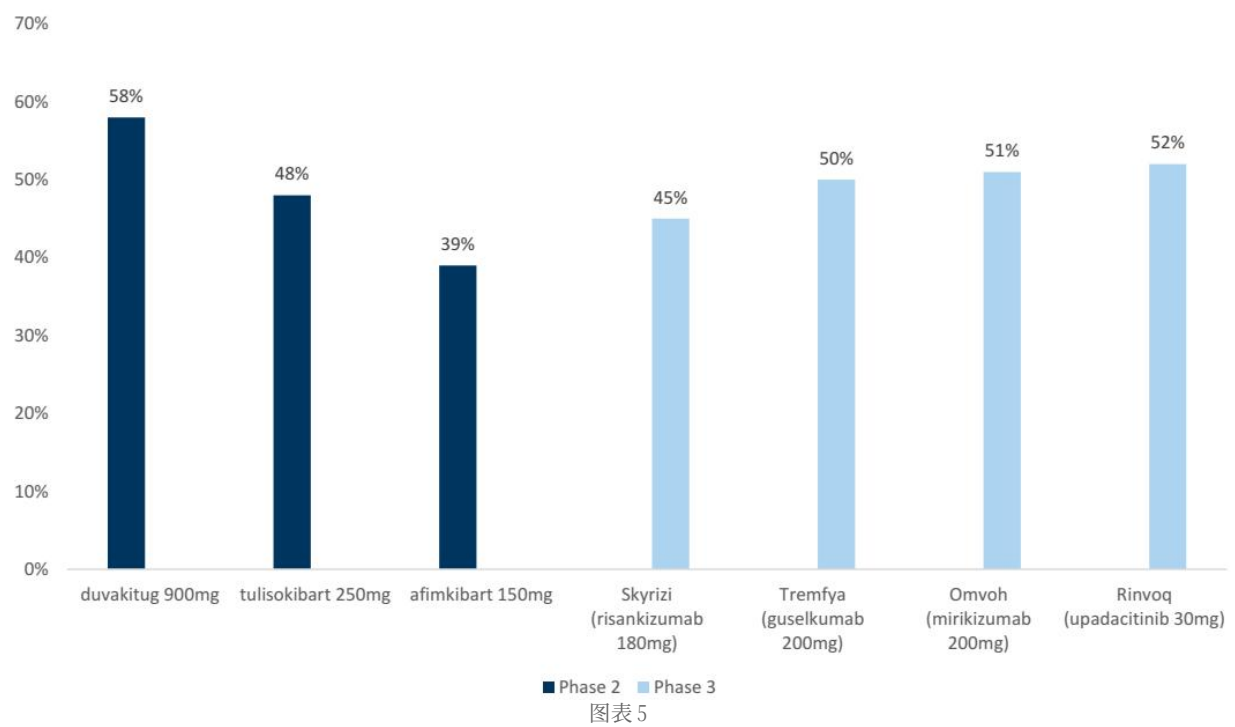
图表4：溃疡性结肠炎诱导期数据



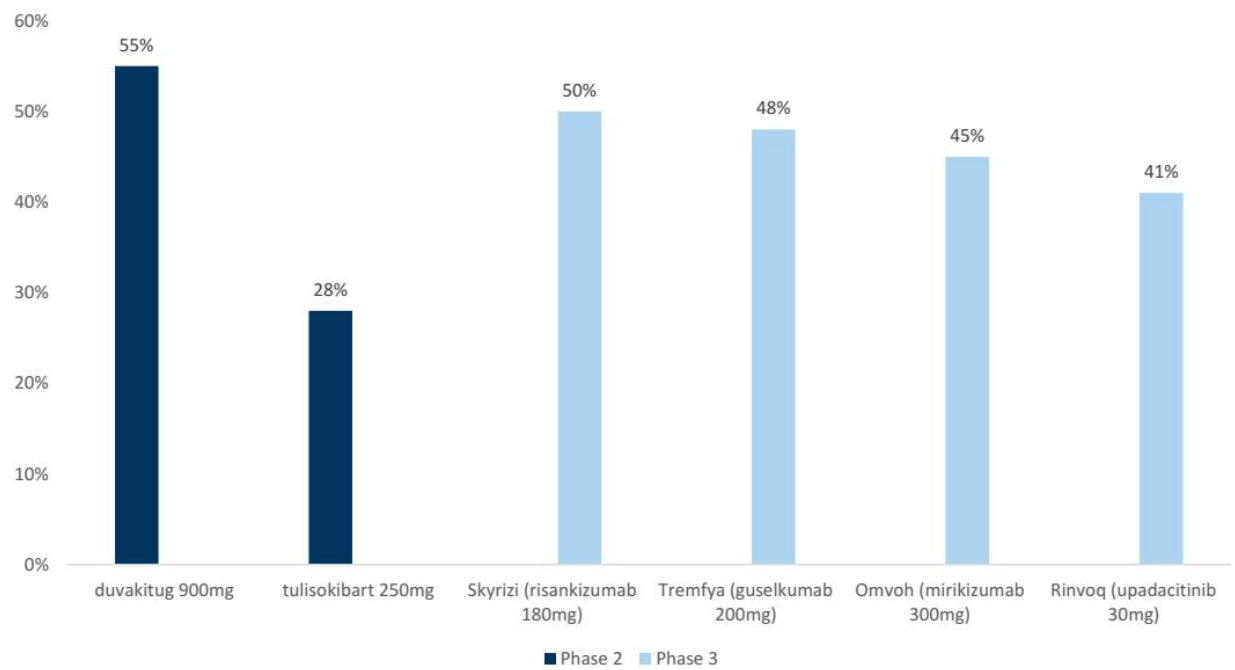
图表5：克罗恩病诱导期数据



图表6：溃疡性结肠炎维持期数据



图表7：克罗恩病维持期数据



图表 6

竞争对手数据：我们认为，在TL1A领域，duvakitug的两个最领先的竞争资产是罗氏的afimkibart和默沙东的tulisokibart，两者均有助于验证该机制，但也围绕差异化和时机引发了竞争性讨论。纵观2期数据集，duvakitug在溃疡性结肠炎中展现了令人信服的疗效信号，并在克罗恩病中具有潜在同类最佳的特征。相比之下，afimkibart显示出可靠的疗效，但安慰剂校正后的响应率较为温和；而tulisokibart则展现出特别强劲的 headline 疗效，这在一定程度上得益于其2期研究中异常低的安慰剂应答率，从而放大了安慰剂校正后的响应率。因此，该类别的一个关键争论点在于，tulisokibart能否在规模更大的3期项目中重现这些安慰剂校正后的获益，因为3期试验中安慰剂应答率通常更高且变异性更大。这一点在默沙东近期更新（参见此处发布）后变得尤为重要，其3期ATLAS-UC试验达到了所有主要和关键次要终点，但详细的疗效和安全性数据尚未披露。如果完整数据集支持快速监管申报并具有竞争力的疗效特征，tulisokibart可能会缩小或消除duvakitug潜在的同类首创优势。相反，如果详细结果公布后安慰剂校正后的疗效显得较为温和，那么关注点可能会越来越多地转向分子层面的差异化，包括duvakitug的持久性、维持期特征以及在炎症和纤维化适应症中的更广泛定位潜力。

图表8：TL1A数据总结

来源：公司数据，clinicaltrials.gov

我们的预测：在我们的模型中，我们纳入了23亿欧元的峰值未经调整销售额，成功概率（PoS）为60%。在其他条件不变的情况下，如果3期结果积极，将降低我们当前60% PoS的不确定性，从而基于DCF的估值带来2%的上行空间；而失败则意味着4%的节奏变化空间。我们目前未将duvakitug在IBD之外的任何重大销售额纳入模型，并假设其作为第三个上市药物，相较于同类最佳疾病数据会抑制销售额（我们正在等待3期试验中确认其同类最佳特征）。

更广泛的TL1A机遇：TL1A抑制剂的机遇远不止于IBD，它代表了一个“药片中的管线”机遇，与免疫介导和纤维化疾病相关。TL1A（TNFSF15）位于炎症级联反应的上游，调节适应性免疫和先天免疫反应，并与组织炎症及纤维化有关，支持多适应症扩展策略，赛诺菲在我们于2026年3月举办的创新峰会上也指出了这一点（参见此处）。

T2（2型炎症）适应症：TL1A在放大Th2驱动的通路中发挥作用，使其成为传统上由IL-4、IL-5和IL-13等细胞因子主导的疾病的潜在治疗靶点。这包括哮喘、特应性皮炎和慢性鼻窦炎伴鼻息肉等疾病。虽然这些市场竞争已很激烈，但TL1A抑制剂可能通过上游通路调节和对组织重塑的潜在影响提供差异化优势，而这在部分患者群体中仍存在未满足的需求。

非T2适应症：除了经典的Th2生物学，TL1A还参与Th1和Th17通路，从而扩大了其与银屑病、银屑病关节炎、类风湿性关节炎和其他自身免疫性疾病的相关性。这为将TL1A抑制剂定位于多个免疫轴交叉的适应症创造了机

会，可能使那些对通路特异性更强的生物制剂响应不佳的异质性患者群体获得疗效。

纤维化适应症：我们认为，最具差异化的机遇可能在于纤维化领域，TL1A与成纤维细胞活化和细胞外基质沉积有关。这包括肺纤维化、系统性硬化症、MASH和其他器官特异性纤维化疾病，这些领域仍存在高度未满足的需求和有限的疾病修饰疗法。TL1A抑制剂的抗炎和抗纤维化双重潜力在此可能特别引人注目，尤其是在有临床数据证明其能影响疾病进展而不仅仅是控制症状的情况下。

默沙东和罗氏的策略凸显了TL1A在IBD之外的广阔机遇。默沙东正积极将tulisokibart扩展到非T2和纤维化适应症，包括类风湿性关节炎、中轴型脊柱关节炎、化脓性汗腺炎和系统性硬化症相关间质性肺病；而罗氏则为afimki bart制定了涵盖T2和纤维化疾病（如特应性皮炎和MASH）的互补策略。虽然IBD仍是赛诺菲/梯瓦的duvakitug近期的核心，但长期价值可能将由向竞争较少、高度未满足需求的适应症扩展所驱动，赛诺菲预计将在这些领域成为快速追随者。

炎症性肠病（IBD）领域的期权价值：赛诺菲在IBD领域的布局不仅限于杜伐凯替（duvakitug），还拥有另外两种机制不同的资产：brivekimig（TNF×OX40L）和balinatunfib（口服TNF抑制剂）。这些资产共同为赛诺菲提供了参与日益增长的免疫学市场的多个机会。重要的是，这些资产针对IBD生物学和治疗范式的不同方面——通过调节炎症和纤维化来抑制TL1A，通过同时靶向炎症和T细胞共刺激通路来实现TNF/OX40L双重阻断，以及一种可能通过口服给药便利性提供生物制剂类似疗效的口服TNF抑制剂。在这三者中，杜伐凯替目前看来是最先进且最具差异化机会的，这得益于其2b期诱导和维持治疗数据的强度，以及TL1A生物学在IBD之外的更广泛生命周期潜力。Brivekimig提供了一种基于TNF的新型下一代疗法，可能通过OX40L调节来改善传统TNF抑制的效果；而balinatunfib则解决了一个长期目标：将TNF阻断的疗效转化为便捷的口服疗法。在一个日益以机制间激烈竞争为特征的市场中，赛诺菲构建了一个包含多种差异化机会的组合观察，覆盖不同的治疗路径，为在不断发展的IBD市场中建立有意义的地位提供了多个潜在途径。

图表9：IBD领域的关键在研资产

* 状态/读出时间基于公司数据或基于主要完成时间的GS估计

艾福多拉普林α（Efdoralprin alpha）

艾福多拉普林α是罕见病管线中的新兴资产，靶向α-1抗胰蛋白酶缺乏症（AATD）相关肺气肿。从机制上讲，它是一种重组AAT-Fc融合蛋白，旨在恢复功能性AAT水平，同时延长给药间隔，解决血浆源性增强疗法的关键局限性。2期ElevAATe研究提供了积极的数据集，证明其在维持AAT水平于正常范围内方面优于标准疗法，并支持更低频率的给药（每3周/每4周一次），在疗效和便利性方面均展现出差异化特征。在美国，赛诺菲预计将在2026年下半年决定现有数据集是否足以支持申报，这表明存在加速获批的潜力。然而，在欧洲，可能需要进行3期结局研究，因此基准预期为2028年读出数据，2028/29年获批上市，以获得更广泛的批准。

AATD相关肺气肿的治疗格局：目前AATD相关肺气肿的治疗格局由四种已获批的血浆源性增强疗法主导——Prolastin-C（基立福）、Glassia（武田）、Zemaira（CSL）和Aralast NP（武田），这些疗法已将α-1抗胰蛋白酶替代治疗确立为标准疗法。这些产品从人血浆中纯化，旨在充分恢复循环AAT水平，以抑制中性粒细胞弹性蛋白酶介导的肺损伤。然而，血浆源性疗法存在若干固有局限性，包括依赖血浆采集和分馏基础设施、供应可变性，以及需要终身每周静脉输注以维持保护性AAT浓度。艾福多拉普林α被设计为一种重组AAT-Fc融合蛋白，可能解决其中一些限制。通过利用Fc介导的半衰期延长，该资产在2期研究中已证明，每3周/每4周给药一次即可将功能性AAT水平维持在正常范围内，与当前增强疗法相比，显著减轻了治疗负担。此外，重组生产消除了对血浆供应的依赖，可能提高可扩展性和供应安全性。因此，如果艾福多拉普林α最终能基于现有数据集在美国获批，或者未来的3期研究能建立足够令人信服的临床特征以支持更广泛的监管批准，该资产有潜力显著颠覆血

浆源性AAT增强疗法市场。

管理层强调的另一个关键角度是与AATD相关的早发性慢性阻塞性肺疾病（COPD）的机会，该疾病目前仍严重诊断不足和检测不足。当前的临床实践通常只在疾病进展后才识别患者，限制了增强疗法的影响。赛诺菲指出，COPD人群中缺乏对AATD的系统性筛查和早期检测是一个重大缺口，表明更广泛的检测采用可以实质性扩大确诊患者群体。在此背景下，艾福多拉普林α不仅可以作为一种治疗创新，还可以作为早期干预范式的催化剂，在发生显著肺损伤之前恢复AAT水平可能具有更大的疾病修饰潜力。如果检测率提高并捕获到更早期的患者，这可能意味着可及市场在传统重症AATD人群之外的实质性扩张。展望未来，艾福多拉普林α的发展轨迹可能不仅由临床结果决定，还取决于该领域如何有效地转向早期诊断和治疗。在COPD患者中，特别是早期或非典型疾病患者中，提高AATD检测的采用率，可以显著增加患者识别，使该资产受益于改善的临床管理和结构性扩张的市场。

我们的估计：在我们的模型中，我们纳入了12亿欧元的峰值未调整销售额，成功概率（PoS）为80%。将我们当前80%的PoS进行不确定性调整，对我们的基于DCF的估值带来1%的上行空间，而失败则意味着5%的节奏变化空间，其他条件不变。

早期管线：公司情况更新

SAR445877 (PD-1 IL-15)

机制：PD-1/IL-15融合蛋白旨在通过将免疫再激活与免疫扩增结合在一个单一构建体中，来解决检查点抑制剂的一个关键局限性。PD-1阻断可去除耗竭T细胞上的抑制信号，而IL-15则驱动CD8+ T细胞和NK细胞的增殖和激活。通过将这些效应共定位，该方法旨在直接在肿瘤微环境内重振和扩增抗肿瘤免疫，特别是在检查点难治性或“冷”肿瘤中。关键的是，将IL-15与PD-1抗体连接可实现更具靶向性的细胞因子递送，这可能相对于早期的系统性IL-15方法改善疗效-毒性平衡。在我们2026年3月的创新峰会上，管理层将该机制描述为生物学上合理且开辟了新的治疗途径，尽管仍处于早期阶段，初步数据在3线转移性结直肠癌（3L msCRC）中显示出前景。

8/11

截至目前的数据：赛诺菲的PD-1/IL-15资产（SAR445877）仍处于早期临床开发阶段，2025年ASCO公布的初步1/2期数据显示，其表现优于该靶点此前的尝试（辉瑞已终止的PD-1/IL-15融合蛋白PF-07209960）。尽管数据集规模较小且处于早期，但这提供了一个初步信号，表明赛诺菲可能在免疫激活与耐受性之间取得了更有利的平衡，而这历来是IL-15疗法面临的关键挑战。

图表10：PD-1/IL-15早期阶段数据

对赛诺菲肿瘤业务的影响：SAR445877代表了免疫肿瘤学领域一个高不确定性、高回报的机会，潜在可触及大型实体瘤市场，尤其是在检查点抑制剂难治性患者群体中。与以往的IL-15疗法相比，早期数据表明赛诺菲的SAR445877可能有望缓解一些关键的历史局限性。然而，该项目仍处于早期且未经证实，关键转折点可能在于这些信号能否在更大规模的2/3期试验中转化为可重复、持久的应答，且不伴随毒性或免疫原性的显著增加。

从战略上看，该资产为赛诺菲在下一代免疫肿瘤学领域提供了选择权，但在现阶段，它最好被视为一个更长期的管线杠杆，而非近期的增长驱动力，其重大价值取决于后续临床不确定性的持续化解。

基因疗法：公司情况更新

赛诺菲的基因疗法管线仍处于早期阶段，但在眼科和神经肌肉疾病领域提供了更长期的选择权，如果临床概念验证得以建立，有望补充其核心业务。该公司正在推进多个基于AAV的项目，包括：(i) SAR446597（Bb C1s AAV）用于地理调整（GA）的1期研究；(ii) SAR402663（sFLT01 AAV）用于湿性AMD的2期研究；(iii) SAR446268（DMPK AAV）用于1型强直性肌营养不良（DM1）的1期研究。这三项资产均基于一次性、持久表达治疗性蛋白的设想，旨在将治疗模式从长期给药转变。

在眼科领域，SAR446597（Bb C1s AAV）正在1期研究中评估用于治疗继发于干性年龄相关性黄斑变性的地理调整（GA）。该项目靶向补体通路失调（GA中已验证的机制），旨在通过单次给药提供持续的眼内抑制，有望

改善频繁注射带来的负担和变异性。SAR402663 (sFLT01 AAV) 正在2期研究中用于湿性AMD，旨在通过基因表达提供持续的VEGF抑制活性，可能减少或消除重复抗VEGF注射的需求。鉴于抗VEGF市场规模庞大且成熟，一种持久的基因疗法方法可能代表治疗模式的重大转变，尤其是在需要频繁给药的患者中。

在湿性AMD的晚期视网膜基因疗法资产中，最先进的项目——艾伯维/REGENXBIO的ABBV-RGX-314、4D Molecular Therapeutics的4D-150以及Adverum Biotechnologies的Ixo-vec (ADVM-022)——已在持久抗VEGF表达和大幅减少注射负担方面显示出令人鼓舞的概念验证。ABBV-RGX-314已显示出持续的玻璃体内抗VEGF表达，同时保持视力并显著减少补救性注射，支持其推进至多个3期研究。Ixo-vec在OPTIC研究中显示年化抗VEGF注射负担减少约80%，同时保持稳定的BCVA和视网膜解剖结构，尽管炎症管理仍是该项目的一个重要关注点。4D-150已产生令人鼓舞的1/2期数据，具有持久的疗效信号，并通过双重VEGF-A和VEGF-C抑制展现出潜在差异化的特征。总体而言，这些项目表明视网膜基因疗法可能越来越接近当前抗VEGF标准疗法的疗效，同时通过单次给药提供治疗负担的显著减轻。然而，尽管有这些令人鼓舞的数据集，我们认为关键争论可能从基因疗法能否减少注射，转向其能否相对于日益持久的可注射抗VEGF疗法，实现足够有利的长期不确定性-获益特征。在我们看来，主要担忧仍然围绕眼内炎症、转基因表达的可控性、长期视网膜安全性，以及医生在慢性疾病（现有疗法已非常有效且负担越来越小）中采用不可逆治疗方法的意愿。

图表11：GA/湿性AMD关键基因疗法管线

在DM1领域，竞争格局正在快速演变，更为复杂，并凸显了基因疗法的机遇与不确定性。目前开发中的方法主要基于siRNA和反义寡核苷酸 (ASO)，旨在减少毒性RNA转录本或调节剪接异常。这些方法受益于成熟的递送平台和更可控的给药方案，但通常需要长期给药，并且根据组织穿透能力（尤其是肌肉和中枢神经系统区域）显示出不同的疗效。相比之下，赛诺菲基于AAV的基因疗法 (SAR446268) 旨在通过一次性干预，从更上游解决疾病问题，靶向潜在的遗传缺陷，并有可能在多个组织中带来持续获益。

虽然预计这些资产短期内不会做出贡献，但在不断变化的研发优先级下，它们可能变得更具战略相关性。在此背景下，即使这些项目中的一个取得成功，尤其是在AMD这样的大适应症或DM1这样高度未满足需求的领域，不仅可能释放增量商业机会，还能增强对赛诺菲创新能力的信心，并有可能使基因疗法随着时间的推移成为管线中更核心的支柱。

- 未实现ROIC > WACC

在新CEO领导下，资本配置政策（特别是业务发展并购）可能是什么样？

我们分析了赛诺菲历史上的并购交易 (>10亿美元)，并估算了每项收购在我们预测期内的ROIC，将这些回报与公司估计的8% WACC进行比较，以评估股东价值创造。我们的分析表明，不同交易类型的结果差异很大，商业交易通常提供最快的价值增值路径，临床阶段补强型交易产生最强的长期回报潜力（尽管管线不确定性更高），而平台型收购需要更大的前期研究和更长的时间线，但在多个资产成功商业化的情况下，可提供有意义的长期ROIC扩张。

图表12：交易及价值创造总结

我们分析的关键要点

■ 商业交易（变革性、补强型及其他商业交易）：商业交易是赛诺菲并购历史中最广泛的类别，其成果因交易规模、资产成熟度和收购估值而存在显著差异。健赞（2011年，201亿美元）是我们分析中唯一的变革性商业交易，根据我们的估算，其在第三年就超过了8%的加权平均资本成本，峰值研究资本回报率达到了约19%，随后随着关键产品成熟而回落至约11%。在商业补强型交易中，回报似乎与估值纪律和商业执行力密切相关。Kadmon（2021年，19亿美元）和Dynavax（2025年，22亿美元）根据我们的估算在三年内超过了加权平均资本成本，产生的峰值研究资本回报率分别约为36%和19%。相比之下，Provention Bio（2023年，29亿美元）在我们的模型期限内未能超过加权平均资本成本，峰值研究资本回报率约为6%，这凸显了回报对峰值销售假设相对于收购成本的敏感性。较大的交易，如Bioverativ（2018年，116亿美元）和Blueprint（2025年，91亿美元），则介于这些结果之间，分别在第六年和第四年超过加权平均资本成本，峰值研究资本回报率分别约为23%和15%。总体而言，商业交易似乎提供了最清晰的近期价值增值路径，尽管最终回报仍取决于收购估值和资产的持久性。

临床阶段补强型交易：我们认为，临床阶段的补强型交易在赛诺菲的并购组合中提供了最强劲的长期回报潜力之一，尽管其时间线更长且管线不确定性更高。根据我们的估算，Principia Biopharma（2020年，37亿美元）预计将在2037年实现约70%的峰值研究资本回报率，这得益于rilzabrutinib和tolebrutinib的峰值销售潜力。Kymab（2021年，14.5亿美元）紧随其后，预计峰值研究资本回报率约为64%，而Inhibrx（2024年，22亿美元）根据我们的估算将达到约36%。然而，价值创造的时间更长，预计Inhibrx在第四年、Principia在第七年、Kymab在第九年研究资本回报率才会超过加权平均资本成本。该类别也承载着重大的二元不确定性，如Synthorx（2019年，25亿美元）所示，其在主要项目终止后导致了完全减值。总体而言，在10亿至40亿美元范围内的临床阶段补强型交易，在赛诺菲能够利用其现有治疗和商业基础设施的情况下，似乎能够产生有吸引力的长期回报。

平台交易：平台收购通常涉及更长的开发周期和前期研究，随着基于底层技术开发出多种资产，回报集中在后期年份。Ablynx（2018年，48亿美元）是我们分析中最清晰的例子，根据我们的估算，其纳米抗体平台预计将在第12年超过加权平均资本成本，并在2037年达到约48%的峰值研究资本回报率，这得益于包括Cabliivi、brivekimig和lunsekimig在内的多个管线资产。Translate Bio（2021年，32亿美元）遵循类似的模式，预计研究资本回报率将在第8年超过加权平均资本成本，峰值研究资本回报率达到约21%，这反映了与mRNA平台相关的更长开发周期。Vicebio（2025年，16亿美元）仍处于早期阶段，无法进行有意义的回报分析。总体而言，考虑到所需的前期研究和更长的商业化时间，平台交易似乎不太适合近期价值增值，但如果该平台能够产生多个商业上成功的资产，则可以支持显著的长期研究资本回报率扩张。

赛诺菲可以做什么？我们对Dupixent专利到期前并购策略的看法 在资本配置和并购方面，赛诺菲的策略一直专注于研究内生增长、寻求选择性的补强型收购、维持渐进式股息以及执行公司回购。在2026年第一季度财报电话会议上，公司指出其通常将目标锁定在20亿至50亿欧元范围内的补强型收购，同时强调如果更大的机会具有吸引力并能带来股东价值，也不会将其排除在外。在2026年3月的创新峰会上，赛诺菲表示预计将在免疫学领域增加活动，在罕见病领域继续但更具选择性地研究，在疫苗领域进行规模调整，并将眼科视为潜在的突破性增长领域。此外，在平台方面，管理层指出将采取聚焦策略，优先考虑单克隆和双特异性抗体等优势领域，预计将有更多资产进入临床，并强调了在血脑屏障穿梭和AAV平台方面的新兴能力。如果我们假设公司愿意将净债务/EBITDA比率提升至3倍（3倍通常是制药公司财务杠杆的历史极限），我们预计赛诺菲拥有约390亿美元的资产负债表容量用于并购，而目前该比率约为0.6倍（GS2026年预期），预计到2027年底约为0.2倍（GS预期）。值得注意的是，公司已表示，在保持AA信用评级的时候，2026年可在业务发展和并购上研究高达150亿欧元。

鉴于Dupixent专利独占权即将到期，我们的研究资本回报率分析表明，赛诺菲可能更适合采取平衡的并购策略，将近期商业补强型收购与选择性临床阶段收购相结合，而不是依赖单一的、大规模变革性交易。商业补强型交易似乎提供了最快的价值增值路径，根据我们的估算，通常在约3年内超过加权平均资本成本，同时还能提供更近期的收入贡献。然而，我们的分析表明，回报对收购估值高度敏感。低于50亿美元范围的临床阶段补强型交易似乎提供了最强的长期回报潜力，根据我们的估算，预计峰值研究资本回报率在约36%至70%之间，尤其是在赛诺菲能够利用其在免疫学、神经学和罕见病领域现有能力的情况下。相比之下，虽然大型变革性收购可以提供即时规模，但我们的分析表明，它们可能带来更为温和的长期回报，同时伴随着更大的整合和资产组合成熟度不确定性，正如健赞随时间推移研究资本回报率下降所显示的那样。

平台收购也可以产生可观的长期研究资本回报率扩张，尽管回报曲线通常是后置的，需要更长的开发周期和大量的前期研究。考虑到Dupixent预期的专利到期时间，我们认为赛诺菲可能会优先考虑具有更清晰中期收入贡献的交易。总体而言，我们的分析支持一种更加多元化的收购方式，将选择性的临床阶段补强型交易与具有商业增值潜力的资产相结合，同时保持严格的收购估值纪律。

其他需要考虑的因素

赛诺菲通过与Alnylam Pharmaceuticals的RNAi治疗联盟，在转甲状腺素蛋白（TTR）领域保留宏观环境利益，据此有权获得Amvuttra的版税，而Alnylam保留全球开发和商业化控制权，因此面临可能影响Amvuttra及相关版税流的动态竞争格局。Amvuttra目前作为ATTR心肌病领域领先的RNAi疗法定位良好，其优势在于约80%-90%的TTR敲低效果、便捷的季度给药方案，以及随着市场转向稳定剂之外而日益增长的临床吸引力。预计Wainua（阿斯利康/Ionis Pharmaceuticals）的III期CARDIO-TTRansform研究将于2026年下半年公布数据，该研究采用高度相

关的主要复合终点（心血管死亡和复发性心血管事件），并允许背景使用tafamidis等稳定剂，这可能会影响竞争格局，尤其是在验证反义疗法并实现目前Amvuttra标签中未反映的联合治疗方案方面取得阳性结果。近期关于试验设计和基线特征的更新已在ESC心力衰竭大会上公布，并指向2026年下半年将获得稳健的数据集，同时我们注意到成功的门槛很高（详见我们的详细报告）。展望更远的未来，nuresiran代表了Alnylam的下一代TTR沉默剂，具有更持久的敲低效果和低频给药的潜力，尽管在我们最近的创新峰会上，一位关键意见领袖将该资产描述为潜在的“游戏规则改变者”，但它不属于赛诺菲的合作范围，未来任何向nuresiran的过渡都可能导致Amvuttra被取代，并相应侵蚀这些版税收入，这对赛诺菲的其他营业收入构成不利因素。

图表13：nuresiran对Amvuttra版税的潜在影响

预测调整：公司情况更新

我们预测的主要更新包括：(i) 对销售额和业务每股收益的汇率更新（对销售额的影响从-2.4%变为-1.3%，对业务每股收益的影响从-3.5%变为-1.9%）；(ii) 在近期III期MOBILIZE研究终止更新后，将riliprubart的成功概率从40%下调至10%；(iii) 在欧盟批准用于非活动性继发进展型多发性硬化症后，将tolebrutinib的成功概率从75%上调至100%；(iv) 纳入23亿欧元债券发行的影响；(v) 我们现在模拟Dupixent从2033年开始的生物类似药进入/价格不确定性，并将终端增长率从0%下调至-2%，以反映研发方面的失望，这意味着对我们的DCF估值产生-4%的影响。

图表14：预测调整

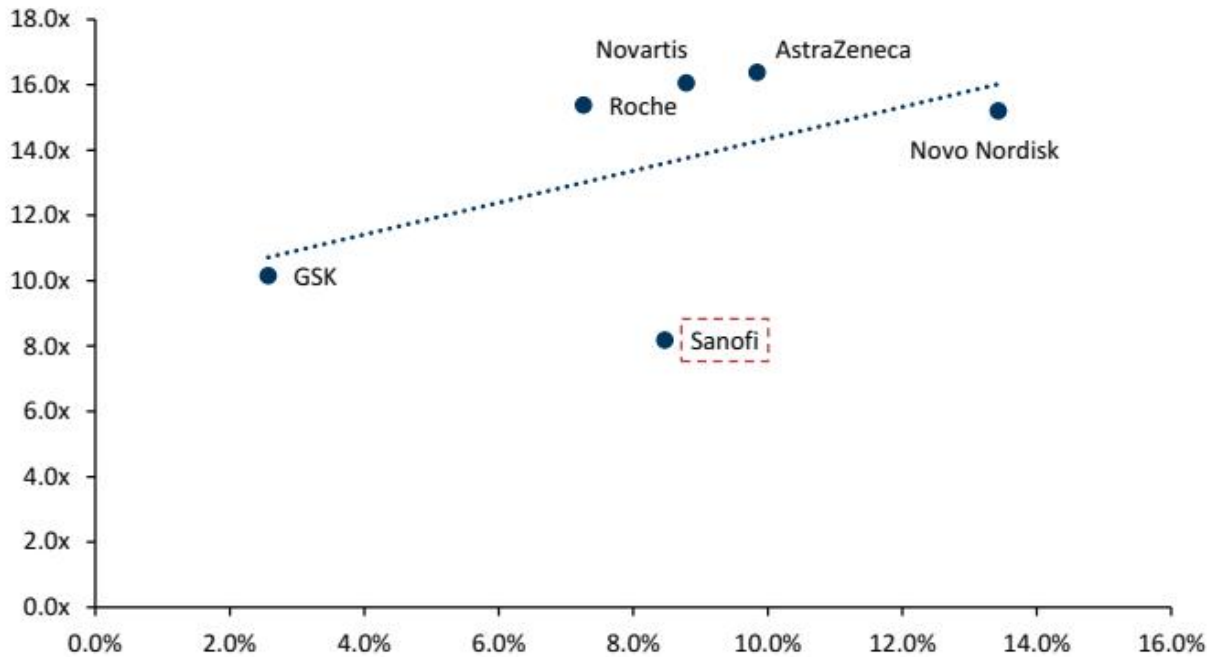
估值：公司情况更新

赛诺菲的2027年预期市盈率为8.2倍，较欧洲生物制药同行折价约35%，市盈率相对盈利增长比（基于2027-30年预期每股收益复合年增长率）约为1.0倍，而同行平均为1.8倍。我们认为，当前的估值折价反映了市场在强劲的近期盈利交付与Dupixent之外增长可持续性的不确定性之间进行权衡。尽管在Dupixent的支持下，公司继续实现稳健的盈利增长，但对下一代增长驱动因素的可见性仍然有限，研发执行尚未产生足以实质性改变读者预期的后期管线成功水平。

在2026年第一季度强劲执行之后，公司正进入一个比较基数较高的时期，管理层对今年剩余时间的前景持谨慎态度。实现两位数的每股收益增长仍然是一个强劲的结果，尽管鉴于我们与2026财年市场预期一致，这似乎已反映在预期中，限制了盈利动能持续的空间。此外，在我们看来，在挑战出现之前，Dupixent专利延期的可见性可能仍然有限，而预期的管线消息流不足以实质性改善读者信心。因此，尽管赛诺菲存在明显的估值折价，但我们认为短期内估值差距缩小的潜力有限。我们认为，贯穿2026年最可能的催化剂是新任CEO的战略更新。然而，任何情绪的改善可能不仅需要可信的战略路线图，还需要成功执行的证明。

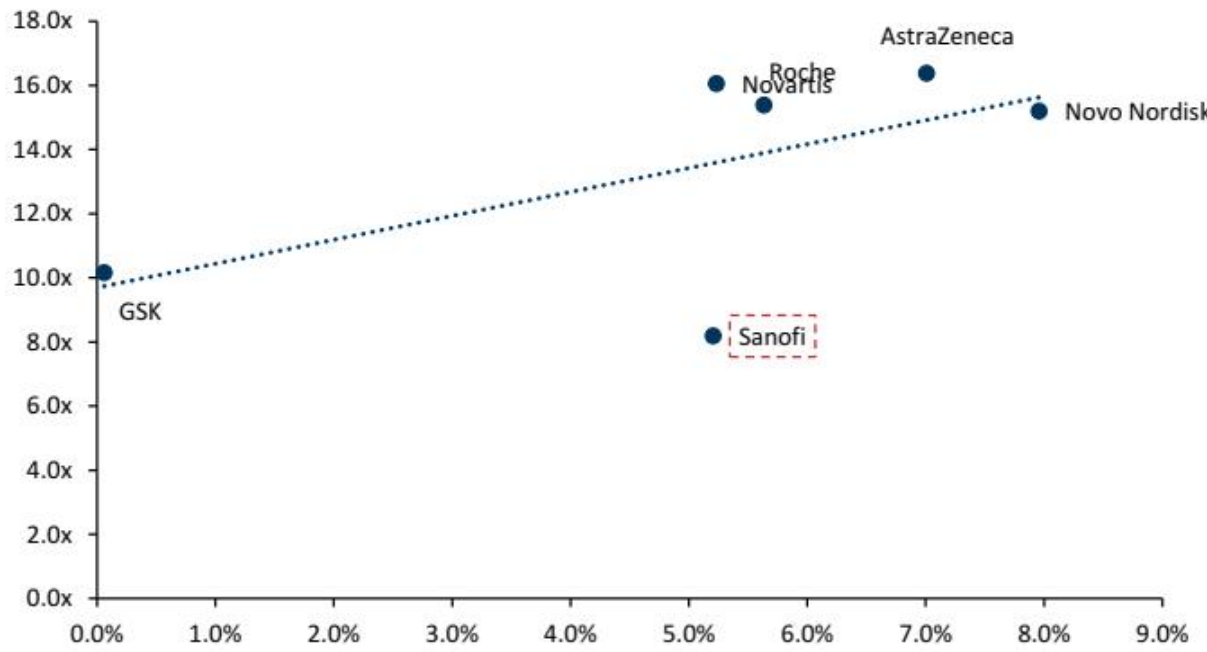
图表15：欧洲生物制药估值汇总

图表16：2027年预期市盈率 vs. 2027-30年预期每股收益复合年增长率：赛诺菲市盈率相对盈利增长比为1.0倍，较同行折价约46%



图表 7

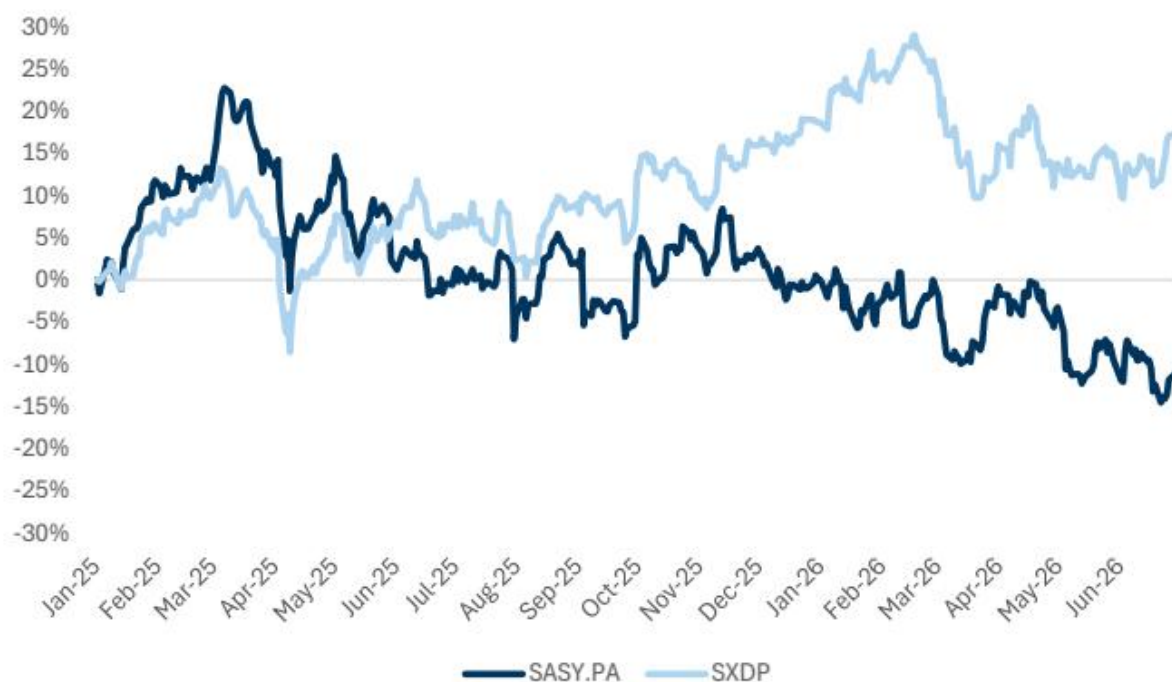
图表17：2027年预期市盈率 vs. 2027-30年预期销售额复合年增长率：赛诺菲市盈率相对盈利增长比为1.6倍，较同行折价约43%



图表 8

自2025年1月以来，赛诺菲的表现明显逊于SXXP指数，报价下跌约11%，而该指数上涨约17%。这种相对弱势始于2025年6月（如图表18所示），并在2025年底以来加速，报价于2026年5月13日跌至五年低点72.72欧元。这较2025年3月创下的历史高点119.16欧元大幅下跌。我们认为，疲软主要是由一系列管线挫折驱动的，这些挫折削弱了读者对公司研发交付能力的信心。主要失望包括itepekimab的III期结果喜忧参半（当日报价下跌5%）、amlitelimab的疗效数据低于预期（当日报价下跌8%），以及tolebrutinib在原发性进展型多发性硬化症中的III期失败及随后的完全回应函（当日报价下跌3%）。尽管公司基本面增长稳健，预计在Dupixent持续动力的主要支持下，2027-2030年销售额和每股收益复合年增长率将高于同行，但市场情绪仍然谨慎。这可以从图表19中看出，市盈率倍数下修是报价表现的关键驱动因素（12个月远期每股收益上调约+13%，12个月远期市盈率倍数下调约-21%）。总体而言，我们认为市场目前正在对这一盈利增长潜力进行折价，原因是缺乏对赛诺菲创新引擎的信心，且近期缺乏同类最佳/首创的管线催化剂。

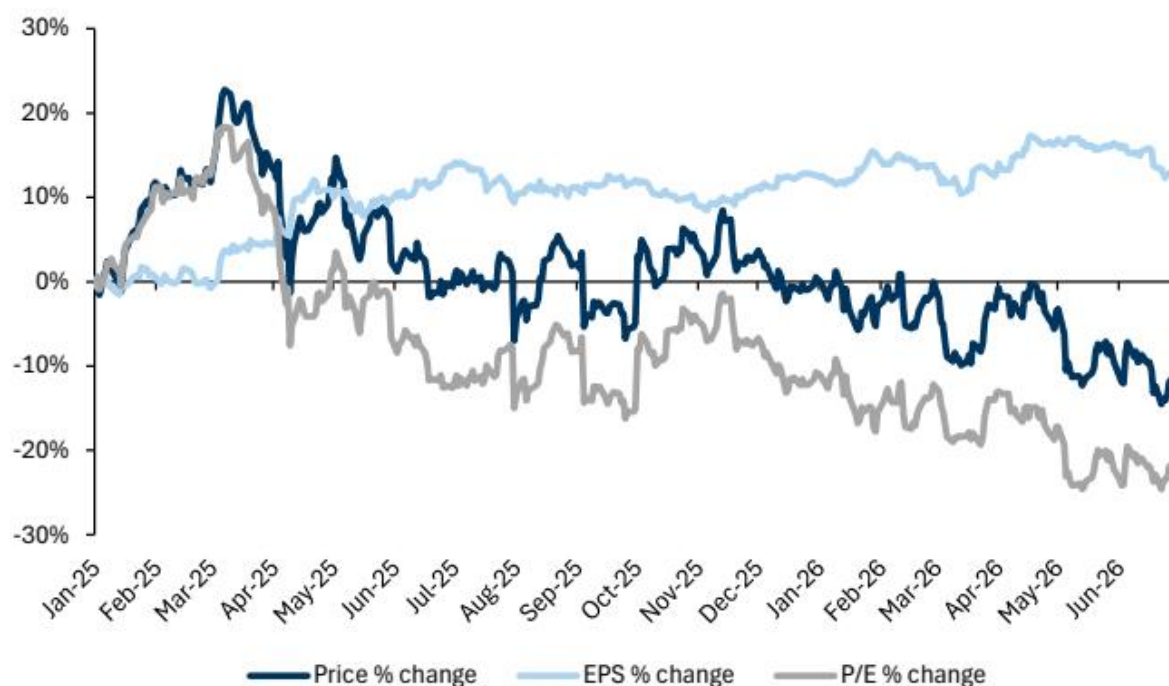
图表18：自2025年1月以来赛诺菲 vs. SXDP指数表现



图表 9

来源：LSEG Data & Analytics

图表19：赛诺菲表现：报价、12个月远期每股收益和12个月远期市盈率



图表 10

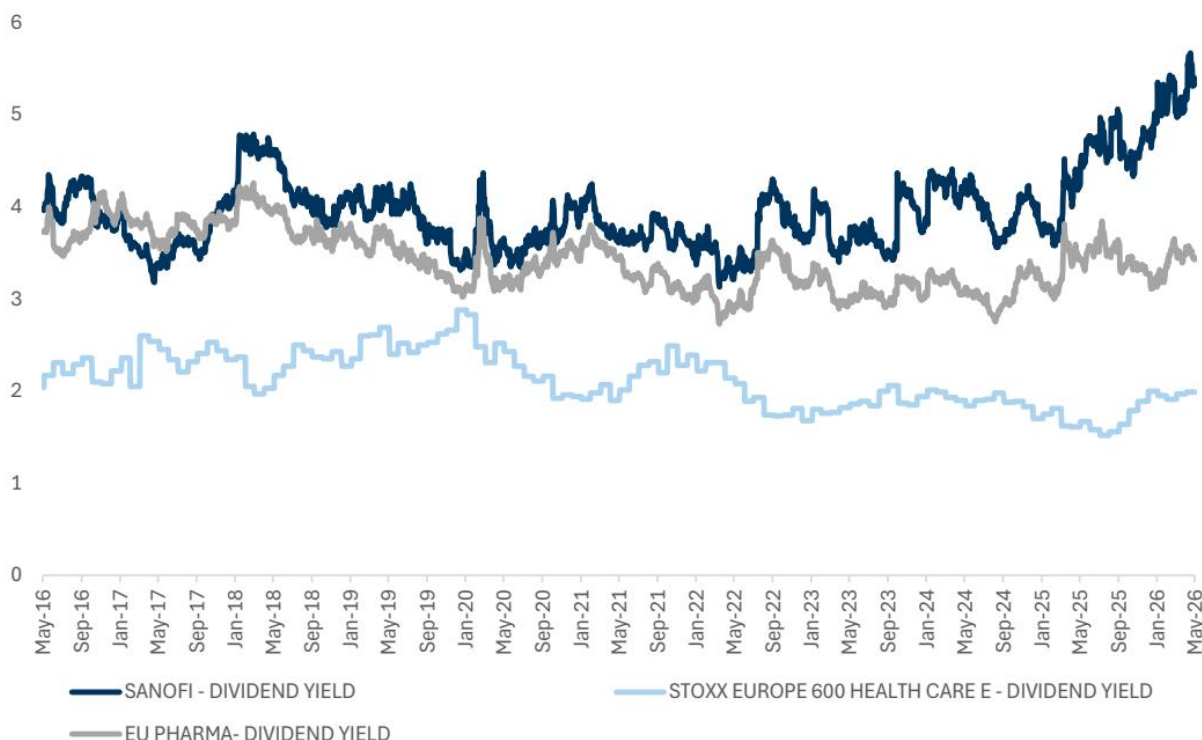
来源：LSEG Data & Analytics

目前，赛诺菲的股息率约为5.5%，而行业平均水平约为3.5%。从历史上看，赛诺菲的股息率略高于行业平均水平，10年平均约为4.0%，而同行约为3.4%，这反映了公司渐进式的股息政策。然而，自2025年5月以来，随着报价从2025年3月的峰值下跌，这一差距开始扩大。虽然持续的股息增长对此有所贡献，但股息率扩大的大部分与报价下跌同步发生。总体而言，尽管较高的股息率加上持续的公司回购，使赛诺菲日益呈现出“价值股”的特

征，但股东总回报仍受到近期报价表现的制约，股息收益仅部分抵消了较弱的资本回报。

展望未来，股东回报要实现更有意义的改善，可能需要市场对公司内部管线交付能力建立更强信心，或通过业务发展（BD）和并购成功实现外部创新。我们认为，BD/并购仍是支持性资本配置框架的重要组成部分，与现有股息和公司回购政策形成互补。

Exhibit 20: Sanofi vs. SXDP and EU Pharma dividend yield



图表 11

来源：LSEG Data & Analytics

公司情况更新

我们更新公司观点。我们采用基于DCF估值与市盈率倍数法各占50%的混合方法。我们的自下而上DCF方法使用8%的加权平均资本成本（WACC）和-2%的终端增长率（TGR，此前为0%，已更新以反映近期研发挫折），得出每股估值83欧元（此前为87欧元）。我们的市盈率方法采用8.5倍目标市盈率，应用于2027年预期每股收益，得出每股估值85欧元（此前为92欧元）。混合后。

公司情况更新

- 强劲的临床管线数据读出，包括二期数据，推动积极市场反应
- Dupixent、Altuviiiio、Ayvakit和Beyfortus的销售增长快于预期，推动盈利动能向好
- 资本配置（即延长当前回购计划或并购）也可能产生积极影响。

节奏变化不确定性

- 临床管线数据读出令人失望，引发对Dupixent长期替代战略的担忧
- 因汇率因素导致短期每股收益共识预期下调，同时长期其他营业收入因计入再生元（Regeneron）支付款项而下调
- Dupixent、Altuviiiio和Beyfortus的销售增长慢于预期。